

Tosse aguda e tosse crônica



A duração orienta o raciocínio, mas sinais de gravidade, contexto epidemiológico e características do paciente definem a urgência.

Aguda
menos de 3 semanas

Subaguda
3 a 8 semanas

Crônica
mais de 8 semanas

Primeiro: procure sinais de alarme

Instabilidade, dispneia importante, hipoxemia, hemoptise, dor torácica, estridor, alteração do sensório, febre persistente, perda ponderal, imunossupressão, risco de aspiração ou exame pulmonar focal exigem avaliação dirigida e, conforme o caso, urgência.

Tosse aguda

Geralmente infecciosa e autolimitada

Causas e diagnósticos a excluir

- Infecção viral de vias aéreas e bronquite aguda.
- COVID-19, influenza e coqueluche conforme circulação e exposição.
- Pneumonia, exacerbação de asma/DPOC, insuficiência cardíaca e tromboembolismo conforme clínica.

Conduta prática

- 1 Avalie sinais vitais, oximetria e exame cardiopulmonar; estime risco de pneumonia.
- 2 Teste agentes específicos quando o resultado modificar isolamento, antiviral ou outra conduta.
- 3 Oriente hidratação e medidas sintomáticas individualizadas. Explique que a tosse aguda pode durar até 3-4 semanas.
- 4 Não prescreva antibiótico rotineiramente para infecção viral ou bronquite aguda não complicada.

Reavalie se houver piora rápida, novos sinais de alarme, ausência de melhora no tempo esperado ou vulnerabilidade clínica relevante.

Tosse crônica

Investigue causas e traços tratáveis

Avaliação inicial

- 1 História: tabaco/vape, exposições, início, gatilhos, expectoração, sintomas nasais, asma, refluxo, disfagia e impacto na vida.
- 2 Revise medicamentos, especialmente inibidores da ECA. A resolução após suspensão pode levar semanas.
- 3 Solicite radiografia de tórax e espirometria; considere broncodilatador, hemograma/eosinófilos e FeNO conforme disponibilidade.

Traços tratáveis frequentes

- Doença eosinofílica das vias aéreas: asma e bronquite eosinofílica.
- Rinossinusite/doença de vias aéreas superiores.
- Refluxo: priorize tratamento quando houver sintomas ou evidência compatível.
- Tabagismo, DPOC, bronquiectasias e exposições ocupacionais.

TC de tórax não é exame rotineiro diante de radiografia e exame normais. Tosse refratária pode refletir hipersensibilidade do reflexo da tosse e merece avaliação especializada.

Quando encaminhar ou ampliar investigação

Achado radiológico, hemoptise, suspeita de neoplasia ou tuberculose, tosse produtiva persistente, infecções recorrentes, dispneia progressiva, alteração funcional, falha de investigação/tratamento inicial ou tosse crônica refratária.

Evite atalhos

Cor do escarro isoladamente não define infecção bacteriana. Supressores inespecíficos, antibióticos, corticoides, broncodilatadores e inibidores de bomba não devem substituir a identificação do diagnóstico ou do traço tratável.